



SAISINE

PASSAGE EN CATÉGORIE B

Corps des ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière

Intersyndicale CGT – SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse

Intersyndicale CGT – SUD Santé Sociaux

Ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière

CHU de Toulouse – Service Transport Patients

Place du Docteur Baylac, TSA 40031 – 31059 Toulouse Cedex 9

Adressée à : **Madame Stéphanie RIST, Ministre de la Santé,
des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées,
Monsieur le Directeur général de l'offre de soins (DGOS),**
14 avenue Duquesne, 75007 Paris.

Fait à Toulouse, le 30 juin 2026

Objet et destinataires

Objet : Demande de révision du classement statutaire du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière — passage de la catégorie C à la catégorie B.

Réf. : Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Art. L. 4393-1 et R. 6311-17 du Code de la santé publique.

Copies : DGAFP · HCPP · CSFPH · FHF · Fédérations nationales CGT Santé & SUD Santé Sociaux · Direction Générale du CHU de Toulouse.

Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général,

Les organisations syndicales CGT et SUD Santé Sociaux, représentant les ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) au CHU de Toulouse, ont l'honneur de vous soumettre la présente saisine aux fins d'obtenir la révision du classement statutaire du corps des ambulanciers hospitaliers, actuellement maintenu en catégorie C en application du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, en vue de son passage en catégorie B.

Cette demande n'est pas une revendication salariale isolée : elle est la conséquence logique et documentée d'une quadruple réalité — un référentiel de formation dépassé par les missions exercées, un précédent statutaire créant une iniquité de traitement entre corps comparables, un risque professionnel cumulatif objectivé par huit sources institutionnelles nationales, et une pratique de classement hétérogène constatée sur pièces dans plusieurs établissements.

I. Contexte réglementaire et situation actuelle

1.1 Un rattachement à la filière soignante sans révision catégorielle

Le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 a procédé à l'intégration des ambulanciers hospitaliers dans la filière soignante de la FPH. Il reconnaît formellement le caractère soignant de leurs missions (articles L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP) mais maintient le corps en catégorie C, créant une contradiction manifeste entre reconnaissance de principe et positionnement indiciaire.

1.2 L'iniquité de traitement avec les aides-soignants — précédent Ségur

Le corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture, titulaire d'un diplôme de niveau 4 RNCP, a été reclassé en catégorie B par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021. Les ambulanciers, dont le DEA est identiquement enregistré au niveau 4 du RNCP, n'ont bénéficié d'aucune mesure équivalente.

Argument-clé :

Le groupe de travail ministériel sur la VAE du 7 novembre 2025 a officiellement reconnu que le niveau de compétences exigé pour le DEA « relève sans conteste de la catégorie B de la fonction publique ».

1.3 Un mouvement social révélateur d'une tension structurelle nationale

Le mouvement de grève engagé au CHU de Toulouse depuis le 7 juin 2026 s'inscrit dans une série de mobilisations inter-CHU documentées : Angers (2021), Tours (2021-2024), Lyon (2022-2024), Marseille (2023-2024).

II. Huit arguments précis et recevables

Argument 1 — Un référentiel de formation structurellement dépassé par les missions exercées

Le référentiel du DEA (arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024) structure la formation en cinq blocs centrés sur la prise en soin générale, le recueil de données cliniques, le transport et l'entretien du véhicule. Il ne couvre pas, ou de façon notoirement insuffisante, les missions suivantes :

- Transports sous contrainte psychiatrique (3 751 missions en 2025 au CHU de Toulouse), transferts UMD/USIP, réintégrations après fugue ;
- Transports pénitentiaires sécurisés (UHSI, UHSA), transferts vers le juge des libertés et de la détention ;
- Transports de patients à risque clinique élevé : soins palliatifs, médecine nucléaire, médecine infectieuse, aplasie médullaire, sorties de bloc/réanimation, patients greffés — manipulation de dispositifs invasifs sans formation dédiée ;
- Transports mortuaires nocturnes, avec gestion relationnelle des familles en détresse ;
- Transports de produits sanguins labiles (PSL) — CHU de Caen Normandie — sans cadre de formation reconnu, hors exigences de la chaîne du froid (arrêté du 10 septembre 2007) ;
- Transports pédiatriques et néonataux spécialisés et prises en soin bariatriques — exemple du CHU de Montpellier : transports de couveuses pédiatriques avec l'équipe du SMUR pédiatrique, exigeant une vigilance spécifique (posologie pondérale, gestion de voies aériennes de petit diamètre, prévention de l'hypothermie du nourrisson, accompagnement psychologique de l'enfant et des parents en situation de stress lors d'un transfert vers un bloc opératoire) ; et prises en soin bariatriques nécessitant un équipement spécifique adapté aux patients en surpoids ou lourdement appareillés. Le bloc 2 du DEA (GSU2) reste un socle généraliste qui ne couvre ni l'un ni l'autre de ces champs. La FAE pédiatrique, bien que fortement recommandée, demeure une formation optionnelle, non certifiante et hors RNCP, accessible de façon inégale selon les établissements ;
- Participation aux Plans Blancs et à la médecine de catastrophe, y compris en remplacement partiel des équipes SAMU.

Argument-clé :

Un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel de formation initiale engage sa responsabilité personnelle sans cadre de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent que la Direction ne peut éluder sans fragiliser sa propre fiche de poste — l'extension aux transports pédiatriques et bariatriques (CHU de Montpellier) confirme que cet écart concerne l'ensemble des CHU, et non un établissement isolé.

Sources : CHU de Toulouse, données d'activité Transport Patients 2025 (56 843 transports patients au total, dont 3 751 transports psychiatriques sous contrainte et 4 033 transports urgences) · Constat intersyndicale CHU de Caen Normandie 2026 (transports PSL hors cadre DEA reconnu) · Constat intersyndicale CHU de Montpellier 2026 (transports de couveuses pédiatriques et prises en soin bariatriques hors cadre certifiant) · Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Argument 2 — Le précédent Ségur : iniquité de traitement objective entre corps de niveau équivalent

La comparaison entre le corps des aides-soignants (AS), reclassé en catégorie B au titre du Ségur de la santé, et celui des ambulanciers de la FPH, maintenu en catégorie C, est entièrement factuelle et documentée : deux corps de diplôme d'État de même niveau RNCP, au sein de la même filière soignante, soumis à un élargissement comparable de leurs actes autorisés.

Critère	Aides-soignants (AS)	Ambulanciers FPH
Diplôme	DEAS — Niveau 4 RNCP	DEA — Niveau 4 RNCP
Durée de formation	~1 400 h (réforme 2021)	~800 h + FAE SMUR optionnelle, 175 h, hors RNCP
Actes autorisés élargis (2021-2024)	Arrêté du 10 juin 2021 (Ségur) : glycémie capillaire, SpO2, soins de stomie, sonde urinaire à demeure, ECG 12 dérivation + transmission, aspiration des sécrétions (trachéotomisé), recueil de données cliniques élargies, aide à la prise médicamenteuse per os, pansements simples, nutrition entérale	Arrêté du 11 avril 2022, modifié le 4 juillet 2024 : paramètres vitaux complets (FC, TA, SpO2, FR, T°, glycémie, EVA/EN), ECG 12 dérivation + transmission régulateur, administration d'oxygène, pose de VVP en urgence (protocole SMUR), aspiration des VAS, immobilisation/contention, RCP + DAE, surveillance de dispositifs médicaux invasifs, protocoles d'isolement protecteur, bilan SAMU structuré + fiche de liaison
Filière FPH	Soignante	Soignante en droit (décret 2022-1658), maintien de fait technique/logistique dans de nombreux CHU
Catégorie	B depuis le 1er octobre 2021	C maintenue à ce jour
Texte de reclassement	Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021	Aucune mesure catégorielle à ce jour

La comparaison est factuelle : deux corps de diplôme d'État de même niveau RNCP, soumis à un élargissement comparable de leurs actes autorisés — l'un reclassé en 2021 au titre du Ségur, l'autre maintenu en catégorie C sans explication documentée. Cette iniquité est directement recevable devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Argument-clé :

Deux corps de même niveau de diplôme (RNCP 4), exerçant dans la même filière soignante et ayant vu leurs actes autorisés élargis selon une logique comparable depuis 2021, ont fait l'objet d'un traitement statutaire radicalement différent. L'absence de toute justification documentée à cet écart constitue, en elle-même, une rupture d'égalité de traitement entre agents publics comparables.

Sources : Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la FPH (Ségur de la santé) · Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH · Arrêté du 10 juin 2021 (Ségur, actes AS) · Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 (actes ambulanciers).

Argument 3 — Le déficit de formation : l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter

Le dossier AFASH (version 02/2026) documente 12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP, et recense 24 missions sur 32 hors périmètre DEA/décret n° 2022-629 (soit les trois quarts).

La France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier spécialisé en urgence pré-hospitalière : Royaume-Uni (HCPC), Allemagne (Notfallsanitäter, 3 ans), Québec (diplôme national), États-Unis (NREMT).

Argument 4 — Un risque professionnel cumulatif objectivé par huit sources institutionnelles

Les données issues de huit organismes institutionnels indépendants convergent pour documenter la spécificité et la sévérité des risques professionnels des ambulanciers hospitaliers :

Source	Donnée clé	Référence
DARES	77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche (37,9 % habituellement + 39,3 % occasionnellement).	Dares Analyses n° 075, octobre 2012
France Travail (BMO 2026)	4 490 projets de recrutement d'ambulanciers — métier classé « en tension » sur 2,28 millions de postes à pourvoir (43,8 % jugés difficiles).	Enquête BMO France Travail 2026
ONVS — Rapport 2025	90 victimes ambulancières recensées en 2023, 85 en 2024 — atteintes aux personnes majoritaires.	ONVS, Rapport 2025, données 2023-2024
CNAM / AT-MP	Risques majeurs : conduite, portage des patients, expositions biologiques — prévention du risque routier classée priorité nationale.	« Ambulancier, un métier à risque ? », Cram Centre Ouest, sept. 2008
INRS	Co-exposition documentée aux TMS et aux RPS chez les conducteurs ambulanciers hospitaliers — recommandations de prévention spécifiques.	INRS, « Transports sanitaires. Les risques du métier »
ANACT — QVCT 2024	Organisation du travail, horaires, management et prévention identifiés comme leviers prioritaires d'attractivité et de fidélisation pour les ambulanciers FPH.	Anact, Référentiel QVCT 2024 ; Les six sujets QVCT, 2025
FNTS / données parlementaires	78 % des entreprises en difficulté de recrutement (FNTS 2024) ; 47 % des ambulanciers déclarent des symptômes d'épuisement professionnel.	FNTS 2024 ; Sénat, question attractivité ; AN, question n° 569
FHF / ANAP	Turnover 18 % annuel, coût estimé 15 000 à 40 000 € par départ — recours à l'intérim 30 à 50 % plus coûteux qu'un agent statutaire.	FHF, décret intérim paramédical 2025 ; ANAP, outil taux de rotation/activité

À ces données s'ajoute l'accidentologie spécifique : le taux d'accidentologie des ambulanciers est 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière, 2023), et entre 57 % et 93 % des ambulanciers déclarent avoir subi au moins un acte de violence verbale ou physique au cours de leur carrière (rapport sécurité des professionnels de santé, 2025).

Argument-clé :

La convergence de huit sources institutionnelles indépendantes — DARES, France Travail, ONVS, CNAM, INRS, ANACT, FNTS, FHF/ANAP — sur la pénibilité, les risques cumulatifs et les tensions de recrutement des ambulanciers hospitaliers constitue une base documentaire incontestable, non susceptible d'être balayée comme une simple revendication syndicale.

Sources : DARES, Dares Analyses n° 075, octobre 2012 · France Travail, BMO 2026 · ONVS, Rapport 2025 · CNAM/AT-MP, Cram Centre Ouest 2008 · INRS, « Transports sanitaires. Les risques du métier » · Anact, Référentiel QVCT 2024-2025 · FNTS 2024 · FHF/ANAP 2025 · Sécurité Routière 2023 · Rapport sécurité des professionnels de santé 2025.

Argument 5 — L'incidence directe du Plan « Zéro contention 2030 » sur le risque en transport

Annoncé le 2 juin 2026, l'objectif national « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030 déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport, sans qu'aucun des leviers annoncés (cartographie, formation à la désescalade, espaces d'apaisement) ne vise à ce stade les professionnels du transport sanitaire.

Argument 6 — Privatisation croissante et argument économique recevable par le DGOS

Le coût annuel d'un passage en catégorie B pour 50 ambulanciers (150 000 à 200 000 €) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes (90 000-150 000 €) et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover 18 % (135 000-360 000 €) + grèves répétées + externalisation.

Argument 7 — Sinistralité routière, abandon de protection institutionnelle et coût humain

Le témoignage d'une ambulancière du CHG Marchant (Toulouse), victime d'une agression routière en juillet 2017, abandonnée par sa direction faute de suite pénale, contrainte de financer elle-même sa défense juridique (gain de cause mi-2024), 10 mois d'arrêt de travail et séquelles psychologiques durables, illustre un mécanisme systémique d'abandon de protection sociale et de précarité indiciaire empêchant l'accès à la défense juridique.

Argument 8 — Une pratique de classement statutaire hétérogène et discriminante, documentée sur pièces dans quatre CHU

[Élément nouveau intégré le 30/06/2026] L'examen comparé de bulletins de paie d'ambulanciers internes en poste dans quatre centres hospitaliers universitaires (Montpellier, Tours, Caen Normandie, Toulouse) révèle que le déficit de reconnaissance statutaire ne se limite pas à un maintien généralisé en catégorie C : dans plusieurs établissements, des agents exerçant en réalité des missions de transport sanitaire hospitalier sont classés sur des grades de catégorie C étrangers au corps des ambulanciers lui-même, sans lien avec le DEA qu'ils détiennent.

- CHU de Montpellier — un ambulancier interne est rémunéré sur le grade 8256 – ASHQ (Agent des Services Hospitaliers Qualifié) classe normale, échelle 8091, indice 366, statut contractuel de remplacement, cotisant à l'IRCANTEC. Aucune mention du métier d'ambulancier n'apparaît sur le bulletin de paie.
- CHU de Toulouse — au sein du même établissement, un second agent affecté à des missions de transport sanitaire est classé sur le grade AEQ (Agent d'Entretien Qualifié), échelle C3, échelon 07, indice majoré 420 — alors qu'un autre ambulancier du même CHU est reconnu au grade « Ambulancier » (échelle NC2, indice 377). Deux classements coexistent ainsi pour des missions comparables, au sein du même établissement.
- CHU de Tours et CHU de Caen Normandie — le grade « Ambulancier » (code 4338) y est correctement attribué, mais avec des écarts d'indice (374 contre 367) et de statut (titulaire à Tours, contractuel à Caen) qui se traduisent par un régime de retraite différent (CNRACL contre IRCANTEC) pour un même intitulé de poste.

Sur la base du volume horaire identique (151,67 h mensuelles) déclaré sur l'ensemble de ces bulletins, l'écart de rémunération nette mensuelle entre l'agent le moins bien classé (Montpellier, ASHQ, 1 767,12 € net) et l'agent le mieux classé (Toulouse, grade AEQ indice 420, 2 412,48 € net) atteint 645,36 €, soit près de 7 750 € par an — pour des agents exerçant le même métier.

Argument-clé :

Cette pratique de classement par défaut sur des grilles ASHQ ou AEQ — constatée dans deux établissements distincts, avec deux intitulés de grade différents, et y compris au sein d'un même CHU — démontre que l'absence de cadre statutaire unifié pour les ambulanciers de la FPH ne produit pas seulement un sous-classement en catégorie C : elle ouvre la voie à un classement discrétionnaire sur des grilles sans aucun rapport avec le DEA, au mépris du décret n° 2022-1658. C'est un argument de rupture d'égalité de traitement entre agents publics exerçant les mêmes missions, recevable devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de nature à appuyer une clarification réglementaire contraignante — et non plus seulement incitative — du classement du corps des ambulanciers.

Pièces jointes à la présente saisine : bulletins de paie (avril et mai 2026) des quatre établissements cités, anonymisés.

III. Proposition opérationnelle — Module de compétences complémentaire au DEA (MHS)

Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS), sur le modèle de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers SMUR (arrêté du 17 mai 2023) — format déjà validé réglementairement, immédiatement crédible auprès des ARS et des CESU.

N°	Module	Contenu et justification
M1	Contrainte et agressivité	Cadre légal de la contrainte psychiatrique, désescalade sans contention mécanique (trajectoire zéro contention 2030), transferts UMD/USIP, gestion de l'agressivité. 3 751 transports sous contrainte en 2025.
M2	Transports sécurisés et pénitentiaires	Conduite sous escorte, protocoles IRIS, coordination pénitentiaire ; transferts UHSI, UHSA. Modèle CHU de Lyon.
M3	Patients fragiles, risque infectieux élevé, pédiatrie et bariatrie	Radioprotection et fin de vie (soins palliatifs, médecine nucléaire) ; asepsie renforcée (médecine infectieuse, aplasie médullaire) ; surveillance et dispositifs invasifs (sorties de bloc/réanimation, greffes) ; transport pédiatrique et néonatal spécialisé avec équipe SMUR pédiatrique ; prises en soin bariatriques avec équipement adapté. [Extension pédiatrie/bariatrie — exemple CHU de Montpellier]
M4	Transports mortuaires	Cadre réglementaire, posture relationnelle, protocoles de sécurité pour interventions isolées hors heures ouvrables.
M5	Médecine de catastrophe et Plan Blanc	Organisation de la chaîne médicale des secours, équivalence partielle FAE SMUR, intégration aux Plans Blancs.
M6	Maintenance de premier niveau	Contrôles et dépannage simples avec outillage fourni. Condition syndicale préalable à toute inscription en fiche de poste.
M7	Spécificités SMUR	Assistance gestes de réanimation, damage control préhospitalier, gestion de scène, NRBC, SSE, coordination interservices, brancardage HéliSMUR. Dossier AFASH 02/2026.

La France est le seul grand pays européen à ne pas reconnaître statutairement ses ambulanciers SMUR ni de filière pédiatrique/bariatrique dédiée. Royaume-Uni (HCPC), Allemagne (Notfallsanitäter, 3 ans), Québec (diplôme national), États-Unis (NREMT).

IV. Demandes formelles

- Ouverture d'une concertation formelle avec la DGOS, la DGAFP et le CSFPH en vue d'une révision du décret n° 2022-1658, aux fins de reclassement en catégorie B ;
- Inscription de cette révision statutaire à l'ordre du jour d'une prochaine instance de dialogue social national de la FPH ;
- Saisine du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) pour intégrer le Module MHS — incluant le volet pédiatrique et bariatrique du module M3 — au référentiel du DEA, sur le modèle de la FAE SMUR ;
- Intégration explicite des ambulanciers de la FPH au volet formation du Plan « Zéro contention 2030 » ;
- Reconnaissance de la FAE pédiatrique comme module certifiant intégré au RNCP, et création d'un module bariatrique dédié, sur le modèle de l'expérience du CHU de Montpellier ;
- Une instruction nationale contraignante de la DGOS rappelant aux établissements que les agents détenteurs du DEA et exerçant les missions d'ambulancier doivent être classés sur le grade « Ambulancier » du corps créé par le décret n° 2022-1658, à l'exclusion de tout autre grade de catégorie C (ASHQ, AEQ ou équivalent), assortie d'un contrôle de conformité auprès des CHU concernés ;
- Entretien avec les représentants des organisations syndicales signataires afin d'examiner les modalités d'un calendrier de mise en œuvre.

V. Références juridiques et réglementaires

- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022
- Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021
- Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024
- Arrêté du 17 mai 2023 (FAE SMUR)
- Articles L. 4393-1 et R. 6311-17 du Code de la santé publique
- Annonce ministérielle Plan « Zéro contention 2030 » du 2 juin 2026
- Groupe de travail ministériel VAE du 7 novembre 2025
- Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles
- Bulletins de paie comparés, CHU de Montpellier, Tours, Caen Normandie et Toulouse, avril-mai 2026.

Pièce jointe — Synthèse exécutive

Argument	Fait clé	Source
Iniquité statutaire Ségur	AS (niveau 4 RNCP) → catégorie B en 2021. Ambulanciers (niveau 4 RNCP) → catégorie C maintenue.	Décrets 2021-1257 / 2022-1658
Référentiel dépassé	3 751 transports sous contrainte non couverts. Transports PSL (Caen) et transports pédiatriques/bariatriques (Montpellier) hors cadre certifiant.	Données CHU Toulouse 2025 · Constats Caen et Montpellier 2026
Tension RH nationale	4 490 postes à pourvoir · 78 % d'entreprises en difficulté · turnover 18 %.	BMO France Travail 2026 · FNTS 2024
Risque violence et accidentologie	90 victimes ambulancières (ONVS 2023) · accidentologie 2,5 fois supérieure à la moyenne.	ONVS 2025 · Sécurité Routière 2023
Privatisation & économie	Coût passage en B (50 agents) : 150-200 k€ < surcoût intérim (90-150 k€) + turnover 18 % (135-360 k€/an).	FHF/ANAP · Hoppi 2026
Sinistralité & abandon institutionnel	Témoignage CHG Marchant : agression 2017, 10 mois d'arrêt de travail, abandon de la direction, gain de cause mi-2024.	Témoignage juin 2026
Disparités statutaires nationales [nouveau]	Grades ASHQ (Montpellier) et AEQ (Toulouse) constatés pour des ambulanciers en poste. Écart net jusqu'à 645 €/mois entre CHU pour le même métier.	Bulletins de paie comparés, 4 CHU, avril-mai 2026

Module MHS — 7 modules : M1 Contrainte/agressivité · M2 Transports pénitentiaires · M3 Patients fragiles, pédiatrie et bariatrie · M4 Transports mortuaires · M5 Plan Blanc · M6 Maintenance · M7 SMUR.

Signataires

Fait à Toulouse, le 30 juin 2026

Pour la CGT :

Julien TERRE

Sébastien GOUSSY

Ahmed HARRAT

Pour SUD Santé Sociaux :

Victor ALAVA

Isabelle PRONO

Représentants du personnel ambulancier :

Laurent BEZIA

Jérôme JEAN-CHARLES